
Periodontia

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Mucosa Oral	4
03 Componentes do Periodonto	5
04 Epitélios Gengivais	8
05 Espaço Biológico	9
06 Epidemiologia e Fatores de Risco	10
07 Controle do Biofilme Dental	11
08 Doenças Periodontais Específicas	12
09 Classificação da Periodontite	13
10 Diagnóstico Periodontal	14
11 Instrumentação Periodontal	15
12 Cirurgia Periodontal Estética	16

01

CONTEÚDO COMPLETO

Introdução

Conceito Geral

PONTOS-CHAVE

A Periodontia estuda os tecidos que envolvem e sustentam os dentes naturais: gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. O objetivo é compreender sua anatomia, fisiologia, alterações patológicas e abordagens terapêuticas.

Etimologia:

Peri = ao redor

Odonto = dente

Funções do periodonto:

Fixar o dente ao osso dos maxilares

Manter a integridade da mucosa bucal



ANOTAÇÕES

02

CONTEÚDO COMPLETO
Mucosa Oral

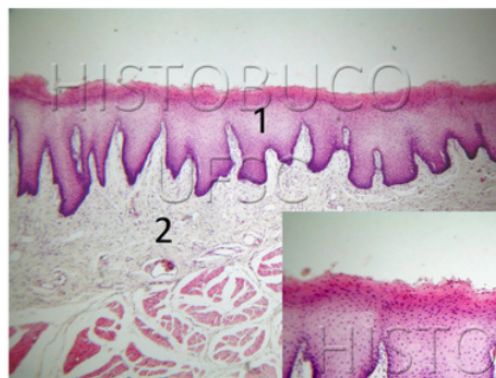
Funções

PONTOS-CHAVE

Barreira mecânica

Percepção sensorial

Secreção salivar

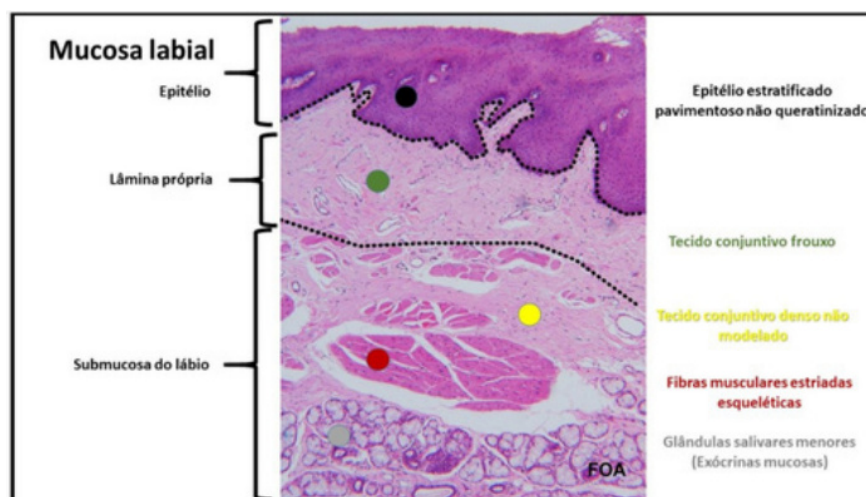
Mastigatória: gengiva e palato duro**Especializada:** dorso da língua**De revestimento:** vestibulo, bochechas, assoalho da boca

Legenda:

1 - epitélio de revestimento da mucosa jugal
epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado

2 - lâmina própria

Camadas de um epitélio não queratinizado:



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Componentes do Periodonto

Gengiva

PONTOS-CHAVE

Composta por epitélio e tecido conjuntivo (lâmina própria).

Funções:

Protege estruturas profundas

Resiste a traumas mastigatórios

Atua como barreira contra microrganismos

Tipos:

Marginal livre: colarinho ao redor do dente

Inserida: firmemente aderida ao osso e ao cimento

Papila interdental: ocupa o espaço entre dentes

Queratinização: Queratinizada até a junção mucogengival.

Características clínicas saudáveis:

Rosa-pálida

Textura firme e casca de laranja

Formato de arcos côncavos

Ligamento Periodontal

Tecido conjuntivo especializado entre o osso alveolar e o cimento.

Características:

Alta vascularização

Inervação intensa

Presença de vasos linfáticos

Funções:

Nutrição

Absorção e distribuição de forças

Sensibilidade

Capacidade regenerativa

Ligamento Periodontal

Principais fibras:

Da crista alveolar

Horizontais

Oblíquas

Apicais

Oxitalânicas

Células presentes:

Fibroblastos

Cementoblastos

Osteoblastos
Restos epiteliais de Malassez

Cimento

Tecido mineralizado que recobre a raiz do dente.

Funções:

Fixação das fibras do ligamento
Proteção e reparo da raiz

Tipos:

Acelular: formado primeiro, sem deposição contínua

Celular: presente no ápice, com cementócitos, deposição contínua

Osso Alveolar

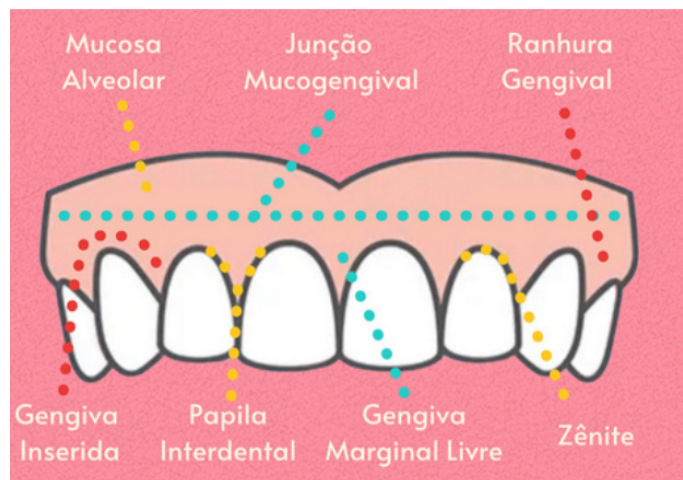
Divisões:

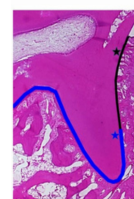
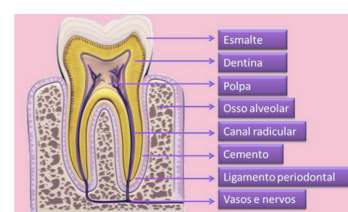
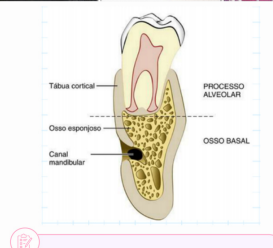
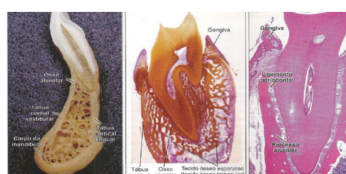
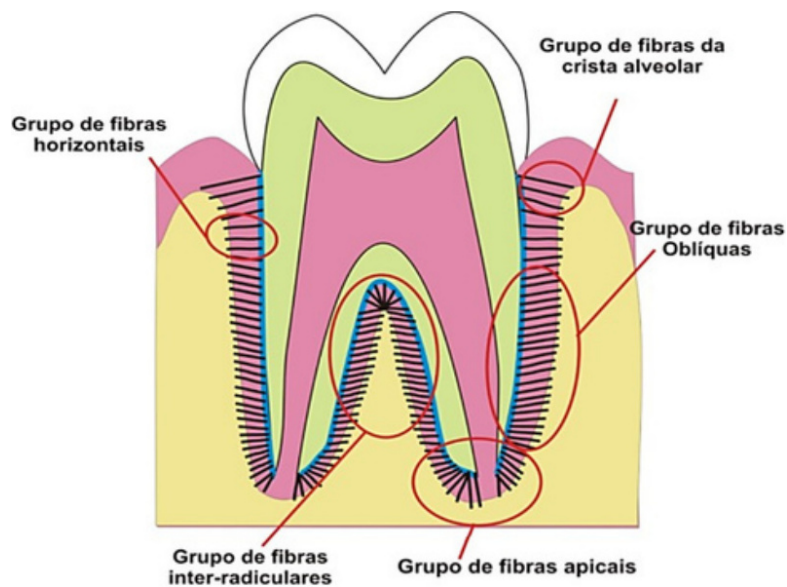
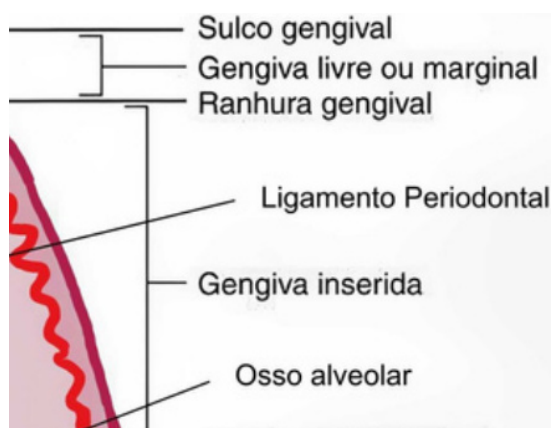
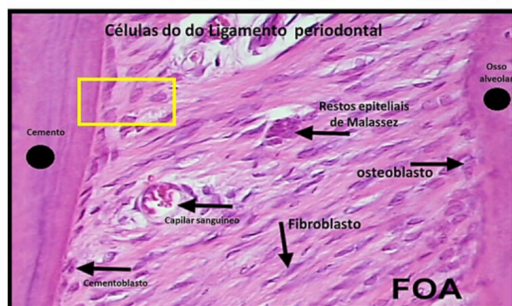
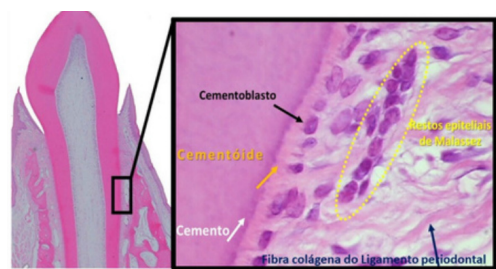
Processo alveolar
Osso alveolar propriamente dito (lâmina dura)
Osso basal

Defeitos ósseos:

Fenestração: ausência de osso sem envolver a parte coronária

Deiscência: ausência óssea na região cervical





CEMENTO: TIPOS MAIS FREQUENTES

- ★ Cimento acelular de fibras extrínsecas
- ★ Cimento celular de fibras mistas (extrínsecas e intrínsecas)

ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Epitélios Gengivais

PONTOS-CHAVE

Epitélio oral

Ceratinizado

Pavimentoso estratificado

Presença de ceratinócitos, melanócitos, Langerhans, Merkel e inflamatórias

Epitélio sulcular

Não ceratinizado

Células cúbicas

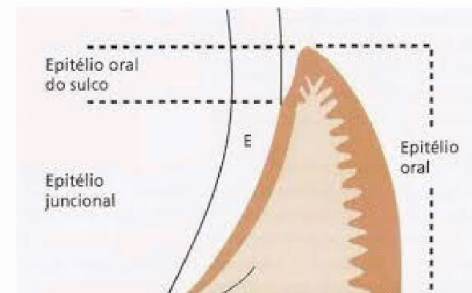
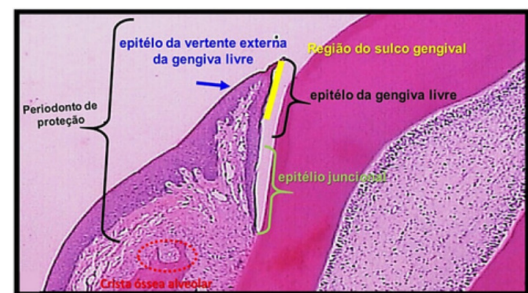
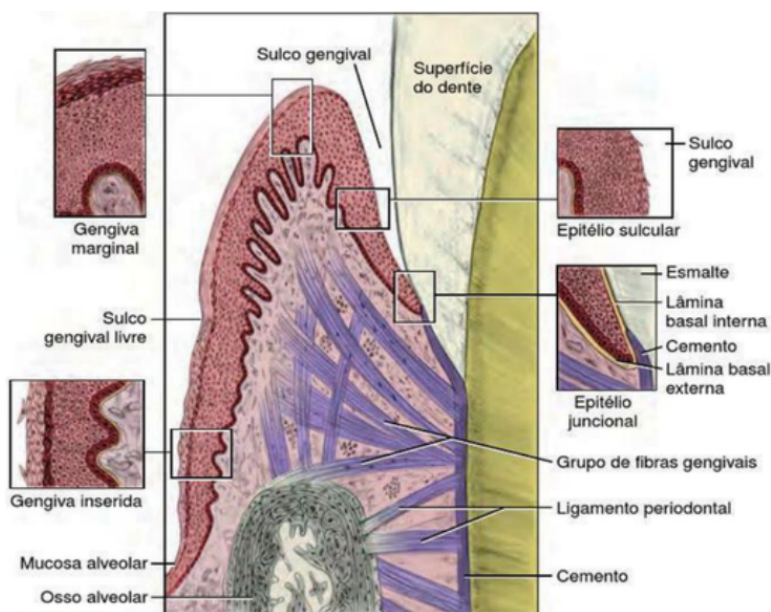
Semipermeável a toxinas bacterianas

Epitélio juncional

Inserção da gengiva no dente

Alto índice de renovação

Aderido ao dente por hemidesmossomos



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Espaço Biológico

PONTOS-CHAVE

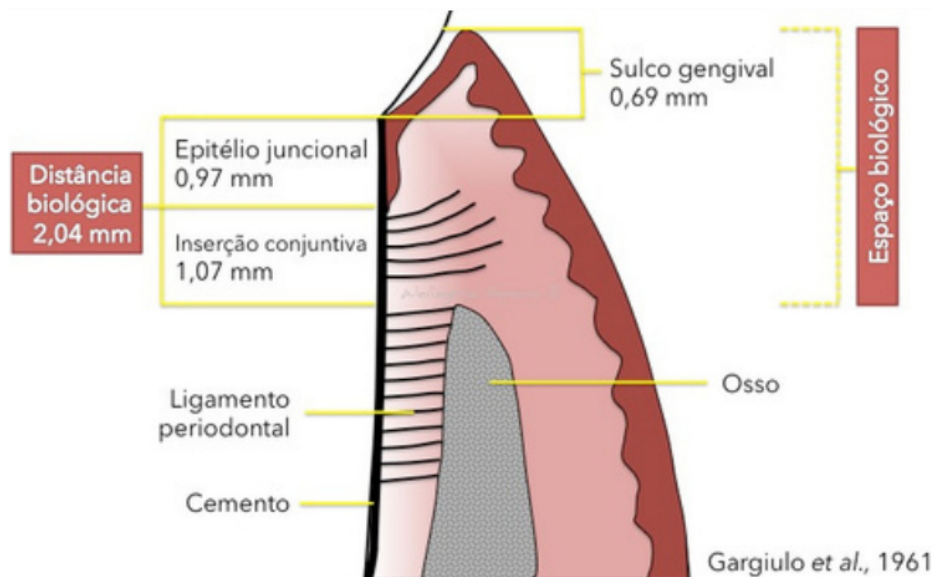
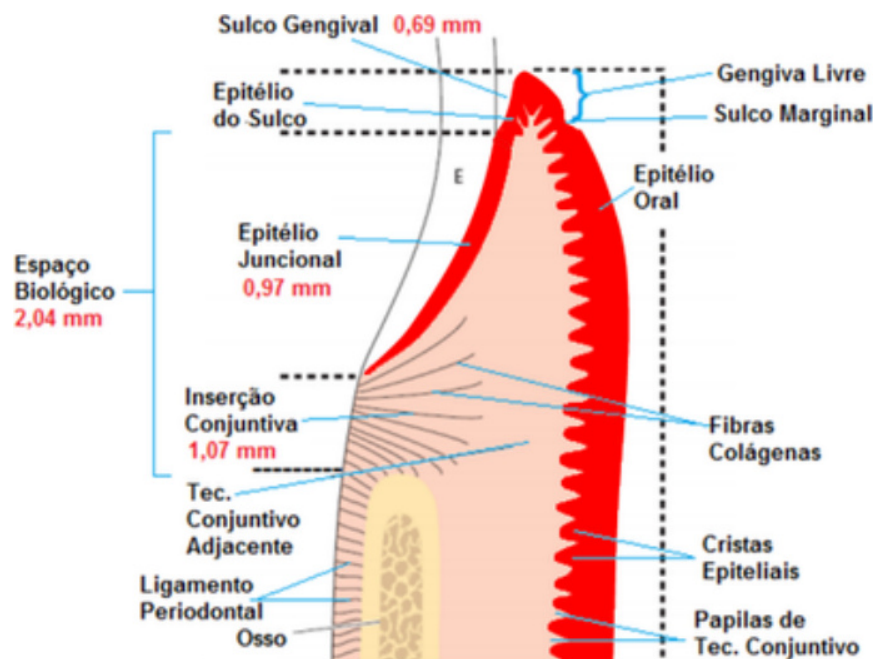
É a distância entre a crista óssea e a margem gengival:

Epitélio juncional (0,97 mm)

Inserção conjuntiva (1,07 mm)

Sulco gengival (0,69 mm)

Total: cerca de 3 mm



ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Epidemiologia e Fatores de Risco

PONTOS-CHAVE

Fatores confirmados:

Tabagismo

Diabetes mellitus

Microbiota patogênica **Fatores prováveis:**

Estresse

Obesidade

Genética

Álcool



ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Controle do Biofilme Dental

PONTOS-CHAVE

Fase inicial: película adquirida → colonização bacteriana → biofilme

Determina a doença: tipo de bactéria + resposta do hospedeiro

Métodos de controle:

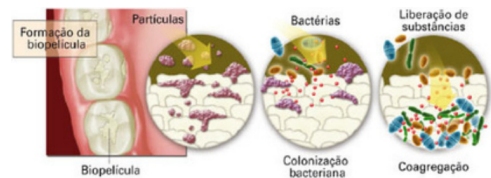
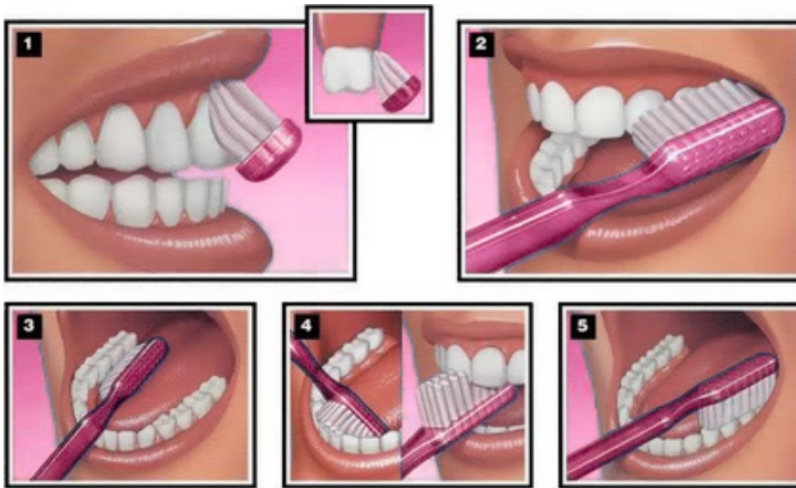
Escovas (manuais, elétricas)

Fio/fita dental, escovas interdentais

Raspar e alisar radicular

Dentífrícios com flúor

Clorexidina 0,12%



ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Doenças Periodontais Específicas

PONTOS-CHAVE

Leucemia: hipertrofia gengival, sangramento

Doença cardíaca: risco de endocardite

Síndrome de Papillon-Lefèvre: perda severa precoce

Lesões:

Abcessos: gengival, periodontal, pericoronário

Gengivite ulcerativa necrosante (GUNA)

Periodontite ulcerativa necrosante (PUNA)

Eritema gengival linear (HIV+)

Gengivoestomatite herpética

Periodontite ulcerativa necrosante (PUNA)

Gengivoestomatite herpética



Eritema gengival linear (HIV+)



ANOTAÇÕES

09

CONTEÚDO COMPLETO

Classificação da Periodontite

PONTOS-CHAVE

Grupos principais:

Saúde gengival e doenças gengivais

Periodontite

Outras condições periodontais

Estágios (gravidade):

Estágio I: perda de inserção até 2 mm

Estágio II: até 4 mm

Estágio III: ≥ 5 mm + perda dentária limitada

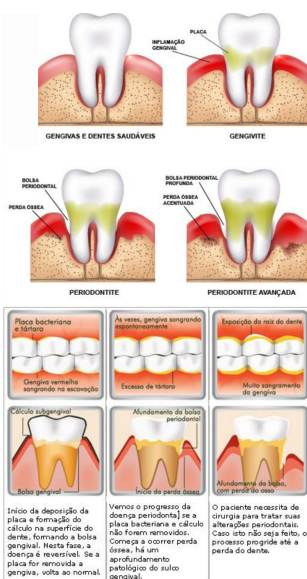
Estágio IV: perda de ≥ 5 dentes, disfunção mastigatória

Graus (progressão):

Grau A: lenta

Grau B: moderada

Grau C: rápida



Graus da Periodontite

A, B e C

Grau A

Característica determinante:

Evidência direta de **não progressão** de perda de inserção por 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de até 0,25 mm.

Características secundárias

Pacientes com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal.

Grau B

Característica determinante:

Evidência direta de **progressão inferior a 2 mm** em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de 0,25-1 mm.

Características secundárias

Destruição compatível com depósitos de biofilme.

Grau C

Característica determinante:

Evidência direta de **progressão igual ou superior a 2 mm** em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano superior a 1 mm.

Características secundárias

A destruição excede ao esperado para a quantidade de biofilme. Padrões clínicos específicos sugerem períodos de rápida progressão e/ou acometimento precoce da doença.

*OBS:

Fatores de risco que podem modificar a graduação:

- **GRAU A:** Sem fatores de risco
- **GRAU B:** Fumantes abaixo de 10 cigarros ao dia ou HbA1c < 7% em pacientes com diabetes mellitus.
- **GRAU C:** Fumantes (10 ou mais cigarros/dia) ou pacientes com diabetes mellitus (HbA1c igual ou superior a 7%).

ANOTAÇÕES

10

CONTEÚDO COMPLETO

Diagnóstico Periodontal

PONTOS-CHAVE

Anamnese:

Queixa principal

Histórico familiar

Hábitos de higiene

Tabagismo

Condições sistêmicas (diabetes, hipertensão, etc.)

Exame clínico e radiográfico:

Alterações de cor, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem

Perdas ósseas:

Horizontal: uniforme

Angular: em diferentes níveis

Índices:

ISS (Índice de sangramento à sondagem)

IPV (Índice de placa visível)

Nível de inserção clínica

Profundidade de sondagem

Mobilidade dentária (Classificação de Miller)

Envolvimento de furca (Classificação I a III)



ANOTAÇÕES

11

CONTEÚDO COMPLETO

Instrumentação Periodontal

PONTOS-CHAVE

Principais instrumentos:

Sondas (Williams, Nabers)

Foices

Enxadas

Limas

Curetas Gracey (1/2 a 13/14)

Raspadores de língua, passa fio, escovas interdenta



ANOTAÇÕES

12

CONTEÚDO COMPLETO

Cirurgia Periodontal Estética

PONTOS-CHAVE

Procedimentos:

Gengivectomia: remoção do excesso gengival**Bisel externo/interno:** técnicas de incisão**Restauração do espaço biológico:** necessário para integridade dos tecidos**Fatores influentes:**

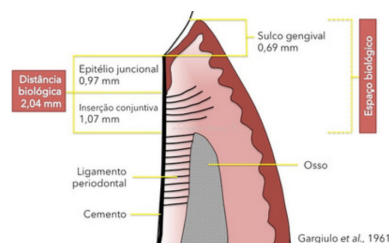
Higiene oral

Presença de biofilme

Tabagismo

Linha do sorriso

Tempo de cicatrização: 21 dias a 9 meses



ANOTAÇÕES

Periodontia II

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Periodontia II 3

01

CONTEÚDO COMPLETO

Periodontia II

Retalhos periodontais

Os retalhos de acesso foram introduzidos para melhorar a eficiência da instrumentação subgengival, obtendo acesso direto à superfície radicular, concavidades radiculares e furcas em sítios com bolsas residuais quando se parte para o tratamento cirúrgico tem duas vertentes

1. Acesso cirúrgico para raspagem 2. Terapias regenerativas/reconstrutivas/ estéticas

EXPOSIÇÃO ÓSSEA APÓS DESLOCAMENTO DO RETALHO:

Retalho De Espessura Total (Mucoperiósteo): Todo o tecido ósseo mole, incluindo o periósteo, deslocado para expor o osso. Periósteo: tecido conjuntivo (camada membranosa) de espessura mais densa e abriga vasos. Indicações:

PONTOS-CHAVE

Aumento de coroa clínica
Bolsas infra-ósseas
Intervenções ósseas regenerativas (enxerto ósseo, por exemplo)

Retalho Inclui somente o epitélio e uma camada de tecido conjuntivo. O osso ainda fica recoberto por uma outra camada de conjuntivo e o periósteo. Indicações:

Deslocamento do retalho
Quando não quer se expor osso
Cirurgias Mucogengivais (enxerto gengival)

POSICIONAMENTO DO RETALHO APÓS CIRURGIA:**Retalho deslocado:**

São reposicionados coronal, lateral ou apicalmente à sua posição original. Retalhos palatinos não podem ser deslocados, por causa da ausência de mucosa alveolar. **Os retalhos total e parcial podem ser deslocados.**

Retalho não deslocado:

Quando o retalho é retornado e suturado na sua posição original.
Pode ser usado na eliminação de excessos gengivais.

MANUSEIO DA PAPILA:

Retalho Convencional:

Papila interdental é dividida abaixo do ponto de contato de dentes vizinhos, permitindo o levantamento dos retalhos vestibular e lingual.

Indicações:

Se tem espaços interproximais muito estreitos

Quando o retalho deve ser deslocado

Retalho com preservação papilar:

Incorpora a papila inteira através de incisões sulculares que separam a inserção conjuntiva e uma incisão horizontal que deixa a papila conectada a um dos retalhos.

Periodontal Flap: são técnicas desenvolvidas para realizar a terapia de bolsa e a correção de problemas morfológicos relacionados, onde uma parte da gengiva e/ou mucosa são afastadas cirurgicamente dos tecidos adjacentes para acesso e visualização do osso e da superfície radicular, podendo deslocar a gengiva para outra posição

Retalho de Kirkland – retalho envelope.

Retalho de Widman – retalho trapezoidal e relaxante, remove tecido gengival e ósseo contaminado – tem retração gengival.

Retalho de Widman modificado – retalho envelope com remoção de tecido mole.

Retalho de Neumann – retalho trapezoidal, não remove colarinho e faz osteoplastia.

Incisões periodontais

INCISÕES HORIZONTAIS:

Direcionadas ao longo da margem gengival **Bisel Externo:** inclinação para coroa dentária e remoção de somente de excesso gengival (ex.: Gengivectomia) **Intrasulcular:** inclinação para a raiz do dente e remoção do pedaço de gengiva, descolamento e acesso ao osso.

Incisão em Bisel Interno ou invertido É a incisão inicial feita em um retalho periodontal, conhecida como incisão primária. Normalmente, é seguida pela incisão sucular e interdental. Indicações:

Usado em grande parte dos retalhos periodontais objetivos:

Remover o revestimento da bolsa bacteriana

Conserva parte da gengiva, que pode ser transformada em gengiva inserida **Incisão Intra-Sulcular**

Feita logo após a incisão em bisel interno, sendo conhecida como incisão secundária.

Feita na base da bolsa, em direção à crista óssea.

Junto com a incisão primária, cria um tecido gengival em formato de "V", que contém grande parte das áreas inflamadas. **Esta incisão é feita ao redor de todo o dente**

Incisão Interdental:

Conhecida também como incisão terciária. Após as incisões em bisel interno e sulcular, é feita a incisão interdental para remoção da gengiva que fica aderida ao dente pela base da papila. Feita após a elevação, quando se tem a separação do tecido gengival do osso.

As 3 incisões horizontais permitem a remoção do epitélio da bolsa e do tecido de granulação adjacente através de uma cureta.

Os retalhos podem ser deslocados usando-se somente a incisão horizontal, se o acesso suficiente puder ser obtido deste modo.

Caso não seja feita uma incisão vertical, o retalho é chamado de “retalho em envelope”.

INCISÕES VERTICAIS:

Oblíquas Relaxantes – trapezoidal:

Utilizadas na extremidade das incisões horizontais, dependendo do objetivo do retalho. São evitadas nas áreas lingual e palatina.

Não devem ser realizadas no centro de uma papila interdental ou sobre a superfície radicular de um dente. Devem ser feitas nas linhas angulares de um dente para incluir a papila no retalho ou para evitá-la.

Reparação:

Reinserção: União do tecido conjuntivo à superfície radicular que possuem um ligamento periodontal viável.

Nova inserção: União do tecido conjuntivo à superfície radicular que necessita de um novo ligamento periodontal.

Regeneração:

Fechamento com recuperação total de forma e função. Formação de novo cemento, ligamento e osso.

Cicatrização:

Fechamento com interposição de cicatriz (deposição de colágeno).

Mas afinal, por que operar?

Acesso para curar

Facilitar o controle de placa pelo paciente e pelo profissional, a vez zerando a bolsa periodontal.

Regenerar a inserção periodontal perdida.

Acesso a raspagem, regenerar, exodontia, instalação de implantes, reconstrução tecidual.

1.**Diérese:** separação dos tecidos através de instrumentos cortantes. 2.**Exérese:** cirurgia propriamente dita.

3.**Síntese:** união dos tecidos.

Procedimento Não Cirúrgico

Seu objetivo é eliminar a inflamação, controlar o biofilme e reduzir a profundidade de sondagem, restabelecendo a saúde dos tecidos de suporte dentário. **Objetivos principais**

Remover placa bacteriana e cálculo subgengival através de raspagem e alisamento radicular (RAR).

Reduzir a inflamação gengival, promovendo cicatrização e readaptação do epitélio juncional.

Restaurar a microbiota subgengival saudável, reduzindo patógenos periodontais.

Melhorar o acesso visual e manuseio tecidual para futuras intervenções, caso necessárias. **Indicações**

Pacientes com gengivite ou periodontite leve a moderada.

Bolsas periodontais com profundidade de sondagem de até 5–6 mm.

Casos em que o paciente apresenta bom controle de placa e adesão ao tratamento. **Crítérios de Sucesso**

Redução da profundidade de sondagem.
Ausência de sangramento à sondagem.
Estabilização ou ganho de inserção clínica.
Melhora da textura, cor e contorno gengival.

PÓS TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO:

Após o tratamento não cirúrgico, ocorre a readaptação do epitélio juncional, formando o epitélio juncional longo, responsável por selar a região tratada e reduzir a inflamação. É comum observar recessão gengival e diminuição do sangramento à sondagem, devido ao aumento da resistência do tecido conjuntivo.

A reavaliação deve ser feita entre 6 e 8 semanas, quando o epitélio já cicatrizou completamente. Pacientes com bolsas de 4 a 5 mm seguem para terapia de suporte, enquanto bolsas maiores que 6 mm ou casos de periodontite estágio III e IV indicam a necessidade de cirurgia periodontal.

O sangramento durante a raspagem ocorre porque o tecido conjuntivo inflamado está exposto, mas tende a desaparecer conforme o processo de cicatrização avança.

Cirurgias mucogengivais / plásticas periodontais

Prevenir/corrigir defeitos de gengiva, mucosa alveolar e osso por fatores anatômicos, de desenvolvimento, traumáticos ou induzidos por doença.

Foco atual: preservação/recuperação tecidual, estética do sorriso e função.

Gingivectomy (tomia = corte; plastia = recontorno):

Antes: usada para "eliminar" bolsas contaminadas.

Hoje: indicada sobretudo para aumentos gengivais (inflamatórios/fibrosos/medicamentosos) e pequenos recontornos sem necessidade de levantar retalho.

Requisitos: espaço biológico (adesão supracrestal) preservado e bolsas suprósseas com faixa adequada de gengiva queratinizada.

Causas de aumento gengival:

Inflamatório (pseudobolsas pela placa).

Medicamentos: anticonvulsivantes (fenitoína), imunossupressores (ciclosporina A), bloqueadores de canal de cálcio (nifedipina), anticoncepcionais em altas doses.

Genético: fibromatose gengival hereditária.

Cirurgia periodontal: lâmina 15C, cinzéis/osteótomos, pontas diamantadas (recontorno), brocas de acabamento, curetas e ultrassom. **Cirurgia de aumento de coroa clínica : Objetivo:**

expor estrutura dentária e restabelecer a adesão supracrestal (pré-endodôntico/pré-protético) e/ou indicação estética (sorriso gengival de etiologia periodontal). **Diagnóstico:**

sondagem transgengival sob anestesia; exames de imagem (p. ex., TCFC); análise do biotipo e da linha do sorriso.

Quando indicar retalho + osteotomia/osteoplastia: quando não há 3 mm disponíveis da margem planejada até a crista óssea.

PASSO A PASSO:

Incisão com bisel interno

Formação do colarinho gengival

Remoção do colarinho

Retalho em envelope de espessura total

Mensurar término restaurador–crista óssea

Reestabelecer a adesão supracrestal (osteotomia/osteoplastia se preciso)

Sutura do retalho em posição estável

Provisório/provisório guiado e finalização protética após cicatrização **Indicação terapêutica por profundidade/estágio (regra prática)**

4–5 mm com boa higiene: preferir terapia não cirúrgica + manutenção.

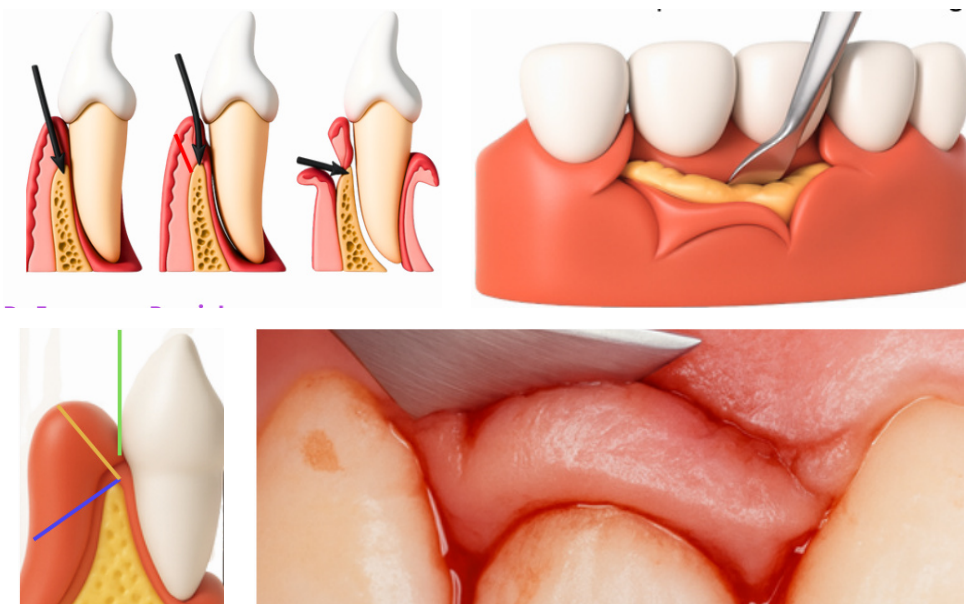
≥6 mm persistentes ou estágios III–IV: provável abordagem cirúrgica (acesso, correção óssea/tecidual).

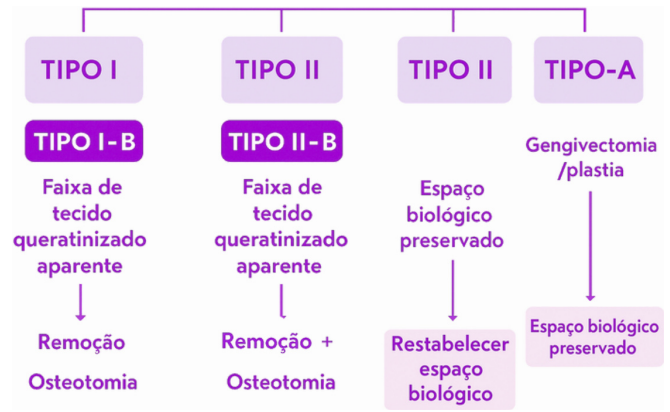
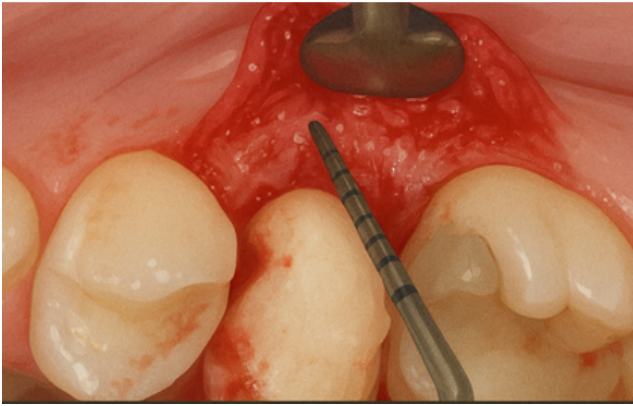
Observações clínicas úteis

Sangramento durante raspagem: tecido conjuntivo inflamado e exposto; tende a reduzir após cicatrização.

Recessão pós-terapia não cirúrgica é comum (resolução do edema) e não significa perda adicional se houver controle de placa.

Planejamento sempre integral: higiene, biotipo, faixa de gengiva queratinizada, arquitetura óssea e exigência protético-estética.





ANOTAÇÕES

Histologia Tecido Conjuntivo

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Tecido Conjuntivo 3

01

CONTEÚDO COMPLETO

Tecido Conjuntivo

Visão Geral

PONTOS-CHAVE

Funções: sustentação, preenchimento, defesa, nutrição, cicatrização e armazenamento de energia.

Componentes principais: células, fibras e substância fundamental.

Diferente dos outros tecidos (epitelial, muscular e nervoso), o tecido conjuntivo se destaca pela **matriz extracelular**, que é mais abundante do que as células

Substância Fundamental

Gel viscoso, transparente, altamente hidratado e incolor.

Composta por macromoléculas como:

Glicosaminoglicanos (GAGs): atraem água, formando uma estrutura gelatinosa.

Proteoglicanos: combinação de GAGs com uma proteína central.

Glicoproteínas de adesão: como a laminina e a fibronectina, que conectam células à matriz.

Atua como **lubrificante e barreira** contra microrganismos.

Células

Fibroblastos e Fibrócitos

Fibroblastos: células jovens, ativas, sintetizam fibras e substância da matriz.

Fibrócitos: células inativas, menores, com menos atividade metabólica. Podem voltar à forma ativa.

Macrófagos: Células fagocitárias, participam da defesa e apresentação de antígenos. Ativados em infecções, podendo formar células gigantes. Presentes em vários órgãos com nomes diferentes (Kupffer no fígado, micróglia no SNC, etc.).

Mastócitos: Células grandes, com grânulos no citoplasma. Armazenam mediadores inflamatórios como histamina e heparina. Relacionados às reações alérgicas do tipo imediata.

Plasmócitos: Produzem anticorpos (imunoglobulinas). Apresentam núcleo com aparência de "roda de carroça". Derivam de linfócitos B ativados, aparecem em áreas com inflamação crônica.

Leucócitos: Migram do sangue para o tecido conjuntivo através da diapedese. Defendem o organismo contra microrganismos invasores. A maioria não retorna ao sangue, exceto os linfócitos.

Adipócitos: Armazenam lipídios em forma de triglicerídeos. Funções: reserva de energia, proteção mecânica e isolamento térmico.

Tecido unilocular: uma gota grande de gordura.

Tecido multilocular: várias gotas pequenas.

Fibras

Fibras Colágenas: Mais abundantes no corpo humano. Proporcionam resistência e sustentação. Formadas por colágeno (principalmente tipo I, II e III). Presentes na derme, tendões e outros tecidos resistentes.

Fibras Reticulares: Formadas por colágeno tipo III. Ramificadas, formam redes de sustentação. Encontradas em órgãos hematopoéticos como baço e medula óssea. São argirófilas (afinidade por sais de prata).

Fibras Elásticas: Compostas por elastina. Conferem elasticidade ao tecido. Presentes na pele, pulmões e vasos sanguíneos.

Tipos

Tecido Conjuntivo Propriamente Dito:

Tecido Frouxo: Mais comum, preenchendo espaços entre órgãos. Apoia o tecido epitelial e envolve vasos, nervos e músculos. Delicado, flexível e com distribuição uniforme dos componentes.

Tecido Denso: Rico em fibras colágenas, oferece resistência e proteção. Subdividido em:

Denso não modelado: fibras desorganizadas, presente em cápsulas de órgãos e na derme.

Denso modelado: fibras organizadas paralelamente, como nos tendões e ligamentos.

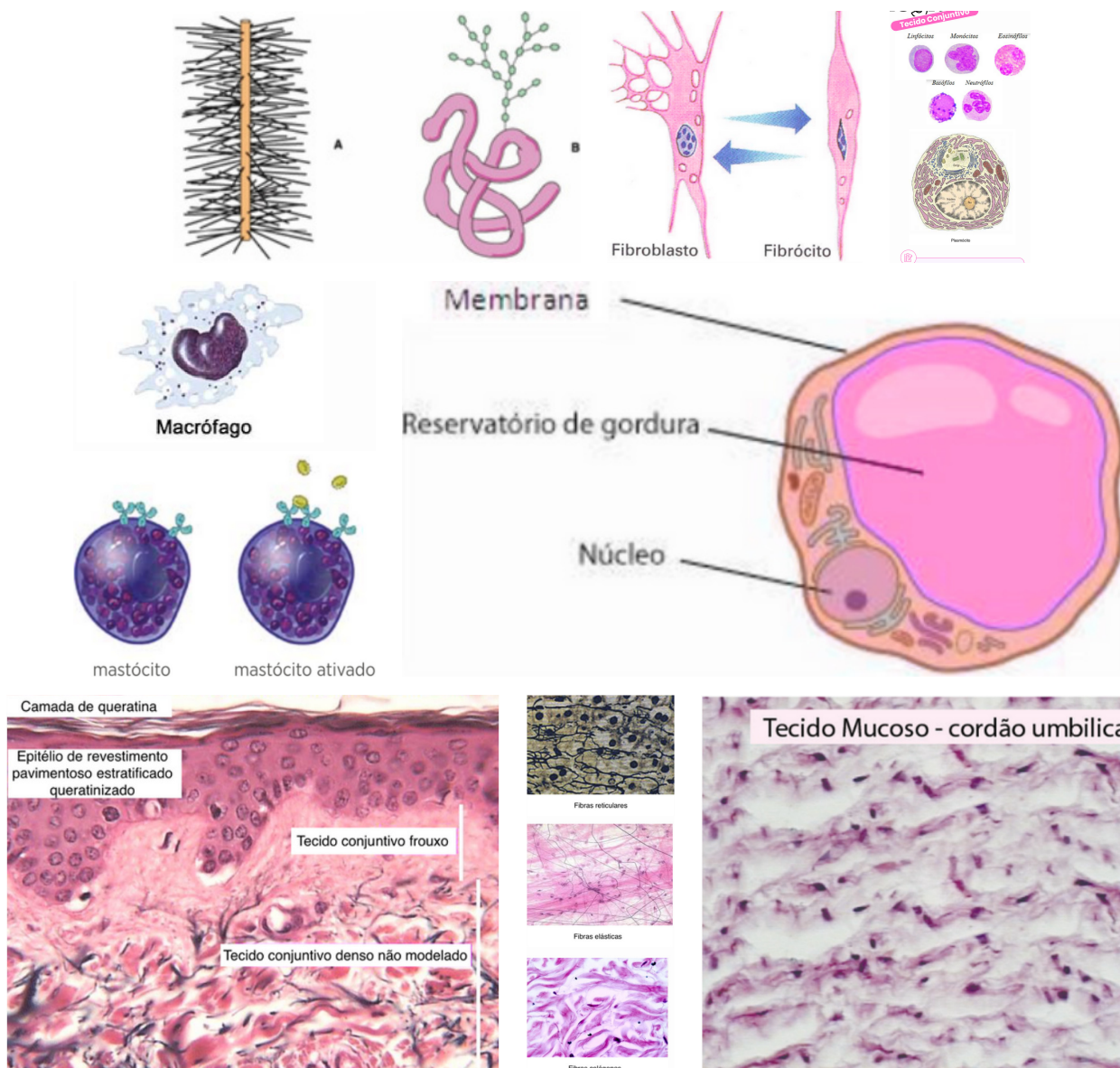
Propriedades Especiais

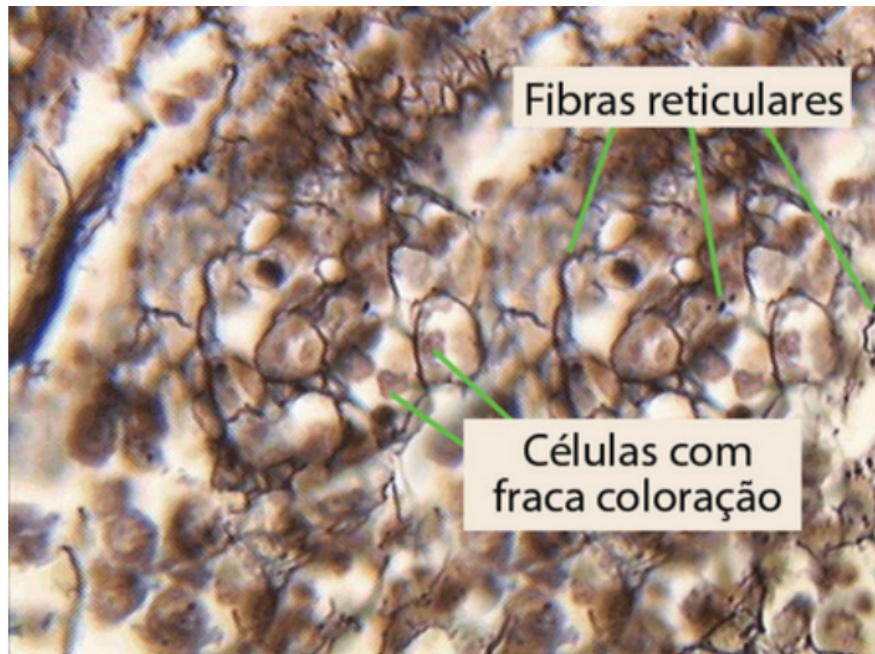
Tecido Elástico: Rico em fibras elásticas grossas. Pouco comum, presente em ligamentos da coluna e do pênis.

Tecido Reticular: Contém fibras reticulares e células reticulares. Sustenta órgãos linfáticos como linfonodos e baço.

Tecido Mucoso: Abundante em substância fundamental, pouco fibrilar. Gelatinoso, presente na gelatina de Wharton (cordão umbilical) e polpa dental jovem.

Tecido Adiposo: Ricos em adipócitos. Reserva energética, proteção contra choques e isolamento térmico. Localizado sob a pele e ao redor de órgãos como coração e rins.





ANOTAÇÕES